

Alle um eine autistische Person in hoch-unterstützter Pflege

Der kumulative Leitfaden für das ganze Team um eine autistische Person in unterstützter / stationärer / hoch-unterstützter Pflege (jedes Alter) — Familie & Angehörige, Ärzt:innen & Pflegeheim-Kliniker:innen, Betreuungskräfte & Assistenzkräfte und Pflege-/stationäre Pflegekräfte. Ein erweitertes Nachschlagewerk; kombinieren Sie es mit den Einzel-Gegenstücks-Kurzanleitungen.

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit einer Person in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Für eine hoch-unterstützte autistische Person sind Pflege-Umwelten oft die **schwersten überhaupt**: sensorisch feindselig, routine-störend, voller unvorhersehbarer Berührung und Anforderung. Viele kommunizieren ohne Sprache (AAC, Verhalten, eine vertraute andere Person) und melden Schmerz vielleicht erst, wenn schwer. Das einzelne, gemeinsame Prinzip für das ganze Team ist radikal und einfach: **lesen Sie jegliches Verhalten als Kommunikation über unerfüllten Bedarf** — Schmerz, Angst, Überlastung oder eine verlorene Routine — und schützen Sie Vorhersagbarkeit, Objekte, Interessen und Handlungsfähigkeit. Würde und Einwilligung hängen daran, *mit* der Person zu arbeiten, niemals Inkapazität anzunehmen.

Was in jedem Setting hilft

- **Untersuchen Sie Schmerz und körperliche Ursachen zuerst** bei jeder neuen Belastung — Verstopfung, Zahnschmerz, Infektion, schlecht sitzende Hilfsmittel sind häufige, verborgene Übeltäter.
- **Bauen Sie Pflege um Vorhersagbarkeit** — konsistentes Personal, derselbe Ablauf, visuelle Zeitpläne, Vorwarnung jedes Wechsels.
- **Senken Sie die sensorische Last** — ruhiger Raum, gedimmtes Licht, weniger Signaltöne und starke Gerüche; bewahren Sie die eigenen Objekte, Interessen und Routinen der Person.
- **Nutzen Sie unterstützte Entscheidungsfindung** — erklären Sie in zugänglicher, wörtlicher Form; gewähren Sie Verarbeitungszeit; konsultieren Sie die vertraute Begleitperson und jedes Vorsorge-/Kommunikations-Profil.
- **Haben Sie einen ruhigen, schriftlichen Meltdown-/Shutdown-Plan:** reduzieren Sie Stimulation, sichern Sie Sicherheit, geben Sie Zeit und Raum — fixieren oder bestrafen Sie nicht.
- **Dokumentieren und teilen Sie ein individualisiertes Sensorik-, Kommunikations- und reasonable-Anpassungen-Profil** über das ganze Team.
- **Halten Sie das Team koordiniert und konsistent** — ein geteiltes Profil und ein einzelner Satz vereinbarter Ansätze über Familie, Kliniker:innen, Betreuungskräfte und Pflege verhindert die Belastung, die Personalwechsel und Missverständnisse verursachen.
- **Planen Sie jeden Übergang und jede Aufnahme im Voraus** — ein schriftlicher „Gesundheitspass“, Fotos des neuen Settings und eine bekannte

Kontaktperson machen die schwersten Momente (Krankenhaus, Umzug, Personalwechsel) zu machbaren.

- **Halten Sie Kommunikationshilfen und AAC verfügbar und funktionierend** — für viele ist AAC *ihre Stimme*; ein fehlendes oder leeres Gerät ist ein Notfall, keine Unannehmlichkeit.

Was Sie in jedem Setting vermeiden sollten

- Belastung als „verhaltensbedingt“ etikettieren, bevor Schmerz und Überlastung ausgeschlossen sind.
- Fixierung oder Sedierung als erste Antwort auf Meltdown/Shutdown nutzen.
- Routinen, Objekte oder Interessen „zu ihrem Besten“ entfernen.
- Von atypischer oder non-verbaler Kommunikation auf Kapazitätsmangel schließen.
- Kommunikationshilfen, Objekte oder Routinen bei Übergängen oder Aufnahmen „verloren gehen“ lassen — Kontinuität ist Sicherheit; dokumentieren Sie sie und geben Sie sie weiter.

Kurzhinweise für jede Person um die Person

Familie & Angehörige

Sie sind ihr Gedächtnis, ihre Anwältin/ihr Anwalt und Kontinuität. Teilen und aktualisieren Sie ein Einseiten-Profil (Interessen, Routinen, sensorische Bedürfnisse, frühe Warnzeichen, was sie reguliert). Bestehen Sie darauf, dass Schmerz zuerst ausgeschlossen wird bei jeder neuen Belastung; schützen Sie Routinen, Objekte und Interessen; drängen Sie auf unterstützte Entscheidungsfindung und einen Gesundheitspass; besuchen Sie und verbinden Sie sich über ihr Interesse.

Ärzt:innen & Pflegeheim-Kliniker:innen

Behandeln Sie neue oder eskalierende Belastung als **medizinisches Warnsignal**, bis Schmerz, Infektion, Verstopfung, Zahnprobleme und sensorische/umweltbedingte Ursachen ausgeschlossen sind. Screenen Sie auf autistisches Burnout unter chronischer Last. Nutzen Sie unterstützte Entscheidungsfindung und einen Gesundheitspass; dokumentieren Sie wirksame Anpassungen.

Betreuungskräfte & Assistenzkräfte (Personal in stationärer Pflege)

Sie sind die alltägliche Umwelt. Konsistentes Personal und derselbe Ablauf, visuelle Zeitpläne, bewahrte Objekte und Interessen, ein ruhiger Meltdown-/Shutdown-Plan (reduzieren Sie Stimulation, sichern Sie Sicherheit, kein Festhalten). Dokumentieren und teilen Sie ein individualisiertes Profil; treten Sie mit Familie und Kliniker:innen ein.

Pflege- & stationäre Pflegekräfte

Schmerz und körperliche Ursachen zuerst; Vorhersagbarkeit und bewahrte Routinen; geringere sensorische Last; unterstützte Entscheidungsfindung; ein ruhiger, schriftlicher Meltdown-/Shutdown-Plan; ein Gesundheitspass für jede Aufnahme. Lesen Sie jegliches Verhalten als Kommunikation über unerfüllten Bedarf.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Behandeln Sie **neue oder eskalierende Belastung** als medizinisches Warnsignal, bis Schmerz, Infektion, Verstopfung, Zahnprobleme und sensorische/umweltbedingte Ursachen ausgeschlossen sind. Screenen Sie auf **autistisches Burnout** unter chronischer Last. Beziehen Sie **spezialisierte Autismus-/Lernschwierigkeiten-Teams** und Logopädie (AAC) ein. Planen Sie jede Aufnahme mit einem „Krankenhaus-/Gesundheitspass“ und einem vereinbarten Meltdown-/Shutdown-Plan, der Sicherheit über Fixierung stellt.

Geschlechter-Hinweis

Hoch-unterstützte Frauen sind besonders unter-erkannt und unter-versorgt; ihre Belastung wird noch häufiger fehl-gelesen. Wenden Sie über das ganze Team dieselbe Sorgfalt beim Ausschluss von Schmerz und Überlastung an, unabhängig vom Erscheinungsbild oder der Kommunikationsmethode.

Über diesen Leitfaden

*KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teil 5, Pflegeheime & Krankenhäuser), der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teile 3.5 & 4) und das **Monotropismus-Dossier**. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein medizinischer Rat und kein diagnostisches Werkzeug**. Passen Sie es an die einzelne Person an; die Familie kennt sie am besten.*

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, Interozeption/Schmerz); Autism Society (2025, Meltdowns/Shutdowns); Leicestershire Partnership NHS Trust (Autism Space); AASPIRE AHAT. Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.